

Indicação Dr. André

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

EDINAMAR DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO

IDADE: 71	PESO: 58	ALTURA: 1,56	PROFISSÃO: Do lar.
SINTOMAS: Engasgo durante os sono, cansaço, fadiga			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Paracetamol / Aterol / Prelin			
MÉDICO: Dr. André Pereira Costa (Otorrinolaringologista)			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR:			
HORA QUE DORME: 0h		HORA QUE ACORDA: 7h	
COCHILO (X) S () N	DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: (X) S () N	DORMEM NO QUARTO: () S (X) N		PET NO QUARTO: () S (X) N
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: Bucal		BANHEIRO/NOITE:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Paralisia de cordão vocal ± 10 anos, realização cirúrgica / Traqueostomia 1 HAS			
CIRURGIAS: () NASAL (X) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA (N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS: CI CPAP IAH = 12,5/20			
POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 CI/CPAP: 76% PRESSÃO NO EXAME: 7 cm H ₂ O			

20/10/24 Avaliação

21/11/24 / 19d usou 10 dias

P = 6 cm H₂O

IAH = 1,7 e/20

m. de uso: 2:59' hr.

Relata que perdeu o sono, por causa de problemas familiares. *João*

Nome: EDINAMAR DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO

Data de Nascimento: 29-5-1953

IMC: 23,83

Sexo: Feminino

Data do exame: 15-09-2024

Peso: 58 kg

Altura: 1,56 m

Médico: DR. ANDRÉ PEREIRA COSTA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia com Titulação CPAP

Exame realizado na noite de 15-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 544,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,5 e 118,5 minutos. O tempo total de sono foi de 326,5 min, eficiência de 60,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,1%; estágio N2: 49,6%; estágio N3: 25,9%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 4,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 12,5/hora, sendo 11 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 57 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e a mínima de 76%, permanecendo 81,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 93 bpm e NREM de 63 - 91 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM diminuída;
3. latência para o sono aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. registro de ronco durante o sono.

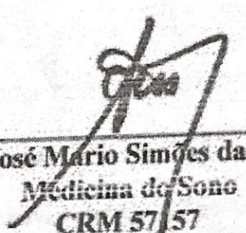
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157